



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نهى عبدالفتاح محمد احمد بحيري

العنوان : اوسيم

الحى / المدينة : اوسيم

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

رقم البطاقة : 28610012128485 رقم التليفون : 01141107601

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-10-1986 المهنة : استرجي

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/ د/ د/ د/

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نهي عبدالفتاح محمد احمد بحري National ID: 28610012128485	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: (score 11).
- Ki67: Positive in 22% of tumor cells.

ASCO-CAP ERPR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, $\geq 1\%$; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate, and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: 'Her2'.

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013 IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar,
Dr. Yoka Medhat

Printing By : mawa mechanical works



Room No. (1) - First Floor-Building No. 9A, Ndc Corralito, Mar. 11 Q, Quito, C. Ecu.

Patient Name : Mrs. Mayada Hegazy
Patient No : 20010012120135
Date No : 3553/24
Sex : Female
Age : 37 Y
Referring Unit :
Request No : 13902480
Request Date : 22/09/2024
Verification Date : 09/10/2024
Financial Category :
Department : Out Patient
Registered by : Mrs Mayada Hegazy

Pathology Report

- * Lymph node involvement: Positive in 4/5 lymph nodes with marked extracapsular extension.
- * Resection Margins: Free deep margin.
- * Histologic response to therapy: Partial pathological response.
- * Microcalcifications: Positive.

Diagnosis:

Right breast cancer post NACT, MRM specimen.

- Bifocal invasive duct carcinoma, grade II.
- Maximal tumor diameter: 3 cm.
- Actual tumor cellularity: 50%, tumor necrosis index: 5+.
- Free deep resection margin.
- Free nipple and areola skin.
- Lymph nodes are metastatic in 4/5 lymph nodes with marked extracapsular extension.
- Partial pathological response to therapy.
- Stage: ypT2a, ypN2.
- RCB: 3.522, RCB class III.

Signature

Dr. Rana Fatmy
Dr. Taka Medhat

Verified by :

Dr. Mervat Mahmoud

Printing Date: 10/10/2024 10:27:49

Page 2 of 2

Printing By : mervat mahmoud yassa

Logo

Ministry of Health and Social Work
Basma No. (H) - First Floor (B) - 985 - Nile Corniche - Min. El-Qadous - Cairo, Egypt

Patient Name : **Dr. Mona Nabil**
Patient No. : **28610012128455**
Path No. : **625/24**
Sex : **Female**
Age : **37 Y**
Referring Doc :

Request No : **13007033**
Request Date : **14/02/2024**
Verification Date : **26/02/2024**
Financial Category : **Out Patient**
Department : **Out Patient**
Registered by : **marwa mohamed youss**

Pathology Report

- PR: Positive (score 6/8)
- Her2: (score 1+)
- Ki67: Positive in 22% of tumor cells.

* Scoring system: 'ER, PR'

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: 'Her2'

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013 IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faintly perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faintly perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Comment: Although Her2 is Negative, such cases (Score 1+) are predictive of response to Her2-Ab drug conjugates (ADCs) according to latest 2023 ASCO-CAP guidelines.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Toka Medhat

Verified by:
DR Menna Nabil

Printing Date: 18/02/2024 11:17:01

Page 1 of 2

Printing By: marwa mohamed youss



18/03/2024, 11:41

MDT Form - Breast Cancer



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:
1- Name: د. محمد أحمد
2-ID number: 28610012128485

Sex:

3- Medical number:
Female
Patient Age: 37 Y

63190791
Old Med:
672/2024



Family history	Phone	01144107601	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT
marital status	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
Co morbidity	Menopausal status	Initial STAGE	Initial STAGE	18/03/2024	0

Clinical data

Breast Imaging: RT breast multicentric looking mass lesion			Mets Workup: C.T-free U/S free		
UX IOC RE COMMENT	ER 8/8 RE COMMENT	PR 6/8 RE COMMENT	Her 2 Recu 1 RE COMMENT	SISH RE COMMENT	K167 22%
Y CT4b multicentric		N 3a	M 0		

Sonomammography

PATIENT HISTORY

Echo, labs

MDT OUTCOME & PLAN

For neoadj ACx4 then Taxotere x4 then MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition
SURGERY			
Psychiatric			



Date : 29/02/2024	Patient Name: Noha Abdel Fattah Mohamed
Age : 37 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN & PELVIS
	Medical ID: 672/2024

**ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION
REVEALED:**

Liver: -

- Average in size (about 14 cm at the right MCL), smooth outline, homogenous echopattern. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent.

Gall Bladder: -

- Average size, normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size (About 9 cm), displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size and site, normal echogenicity, no stone or backpressure changes, no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed: -

Uterus: - anti-verted, average sized uterus. Endometrial thickness measures about: 6.

Ovaries: - both are average in size with no dominant follicle could be detected.

No free fluid in the Douglas pouch.

Opinion:

Unremarkable study

Best Regards,
Dr. Dina Gaber FEBR,

Not Approved